Remission, Alltag und persönliche Recovery

Besserung ist möglich. Diagnostische Remission, Alltag und Teilhabe sowie persönliche Recovery beschreiben unterschiedliche Aspekte und müssen sich nicht gleichzeitig verändern.

VIER BEGRIFFE – UNTERSCHIEDLICHE BLICKWINKEL

1

Diagnostische Remission

In Verlaufsstudien bedeutet Remission, dass die Diagnosekriterien während eines festgelegten Zeitraums nicht mehr erfüllt sind. Die genaue Definition und die verlangte Dauer unterscheiden sich zwischen Studien. Remission bedeutet nicht automatisch, dass alle Beschwerden verschwunden sind oder keine Unterstützung mehr nötig ist.

2

Alltag und Teilhabe

Beziehungen, Arbeit oder Ausbildung, Wohnen und Alltag sind eigene Lebensbereiche. Sie können sich anders und in einem anderen Tempo verändern als Symptome. Erneute Beschwerden oder Belastungen machen bereits erreichte Veränderungen nicht ungeschehen.

3

Persönliche Recovery

Persönliche Recovery beschreibt einen individuellen Weg zu einem selbstbestimmten und als sinnvoll erlebten Leben. Dazu können Hoffnung, Verbundenheit, Identität, Teilhabe und eigene Handlungsmöglichkeiten gehören. Welche Ziele bedeutsam sind, bestimmt die betroffene Person selbst.

4

Zum Begriff «Heilung»

«Heilung» wird unterschiedlich verstanden und ist bei Borderline kein einheitlich definierter wissenschaftlicher Endpunkt. Für sachliche Informationen sind präzisere Begriffe wie Remission, Funktionsfähigkeit, Lebensqualität und persönliche Recovery hilfreicher. Eine Einteilung in «geheilt» oder «für immer krank» wird individuellen Verläufen nicht gerecht.

VERÄNDERUNG HAT MEHRERE SEITEN

Symptome, Funktionsfähigkeit, Lebensqualität und persönliche Recovery können sich unterschiedlich entwickeln. Ein einzelner Begriff beschreibt nicht den ganzen Genesungsweg.

EIN NÄCHSTER SCHRITT

- Vermeiden Sie Vorgaben von aussen dazu, wie schnell oder wie weit Veränderung gehen soll.
- Fragen Sie die Person, welche Veränderungen für sie selbst bedeutsam sind, statt Fortschritt von aussen festzulegen.
- Nehmen Sie erneute Belastungen ernst, ohne sie als persönliches Scheitern zu deuten.

Eigene didaktische Darstellung der Fachstelle Angehörigenarbeit. Fachlicher Bezug: APA Practice Guideline for the Treatment of Patients With Borderline Personality Disorder (2024); NICE CG78; Zanarini et al. (2012, 2024); AWMF-S3 Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen (2025), Kap. 7.1.

Dieses Blatt ersetzt keine persönliche Beratung oder Behandlung.

Für Angehörige – Fachstelle Angehörigenarbeit, PUK Zürich – Ch. Egger | Entwurf – fachlich-redaktionelle Freigabe ausstehend | Stand: 05.10.2026.